

CAPÍTULO 8.7

RGE, Úlcera Gastroduodenal, Dispepsia Funcional y H. pylori

PERFIL EUNACOM 1.06.1.027

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Reflujo, Úlcera Péptica, Dispepsia y H. pylori

Reflujo Gastroesofágico (RGE)

Patogenia

Relajación transitoria del esfínter esofágico inferior (no es una obstrucción, es funcional).

Clínica

TABLA 8.7.1: PRESENTACIÓN VS SÍNTOMAS

PRESENTACIÓN	SÍNTOMAS
Típica	Pirosis + regurgitación ácida
Atípica	Tos crónica, asma, disfonía, caries/erosiones dentales

Diagnóstico

- Cualquiera de las siguientes **confirma** el diagnóstico:
- Clínica típica** (pirosis + regurgitación) → no requiere exámenes
- pHmetría de 24 h** (gold standard): indicada ante duda diagnóstica o clínica atípica
- Endoscopia** (esofagitis distal): no se pide por sospecha de RGE, pero si se encuentra esofagitis durante otra indicación → diagnóstico hecho

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si el paciente con RGE típico presenta **signos de alarma** (disfagia, baja de peso, hemorragia, síntomas nocturnos que lo despiertan) → endoscopia obligatoria para descartar complicaciones o cáncer.

Tratamiento

- 1. Medidas generales:**
- Alimentación fraccionada
- Levantar cabecera de la cama (reduce reflujo nocturno)
- Evitar alcohol y benzodiacepinas/relajantes musculares antes de dormir
- 2. Fármacos:**
- Elección:** IBP (omeprazol, lansoprazol, esomeprazol) → tomar en ayunas 30 min antes de comer
- Anti-H2 (ranitidina, famotidina): obsoletos, desplazados por los IBP
- Contraindicado:** usar IBP + anti-H2 juntos

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si hay que elegir entre ranitidina y omeprazol → **siempre omeprazol**. Si dan la mezcla → también omeprazol.

- 3. Cirugía (funduplicatura de Nissen):** indicada en:
- Esófago de Barrett con displasia de alto grado
- Paciente joven con síntomas intensos que no responde a IBP (riesgo de Barrett a futuro)

Esófago de Barrett

- Clínica:** asintomático (síntomas son del RGE subyacente)
- Definición:** metaplasia intestinal del epitelio esofágico (epitelio cilíndrico en vez de plano)
- Riesgo:** progresión a adenocarcinoma de esófago

TABLA 8.7.2: BIOPSIA MUESTRA VS CONDUCTA

BIOPSIA MUESTRA	CONDUCTA
Metaplasia sin displasia	IBP + endoscopia de seguimiento anual
Displasia de alto grado	Cirugía (esofagectomía)

NOTA CLÍNICA

El diagnóstico de Barrett es la biopsia con **metaplasia**. El factor que determina la cirugía es la biopsia con **displasia** (son dos conceptos distintos, no confundir).

Úlcera Gastroduodenal

Causas

TABLA 8.7.3: CAUSA VS ÚLCERA GÁSTRICA

CAUSA	ÚLCERA GÁSTRICA	ÚLCERA DUODENAL
H. pylori	70%	90%
AINEs	Sí	Sí
Corticoides, cigarrillo	Sí	Sí

Clínica: Síndrome Ulceroso

- Epigastralgia **urente** (quemante)
- Aumenta con el ayuno** → disminuye con ingesta de alimentos o antiácidos

Diagnóstico

- Endoscopia digestiva alta** (siempre, para):
- Confirmar la úlcera
- Descartar cáncer gástrico (misma clínica)

Tratamiento

- Úlcera en general:** erradicar H. pylori (+ suspender AINEs si aplica)
- IBP se agrega 6 semanas como adyuvante a la cicatrización (no es el tratamiento, es complementario)
- Sin erradicación:** recidiva en 90% de los casos

EUNACOM CRITERIOS

El **omeprazol** es el tratamiento del **reflujo**. La **erradicación de H. pylori** es el tratamiento de la **úlcera**. No confundir estas indicaciones.

¿Cuándo erradicar?

TABLA 8.7.4: SITUACIÓN VS ¿ERRADICAR?

SITUACIÓN	¿ERRADICAR?
Úlcera duodenal (cualquiera)	Siempre (incluso si H. pylori es negativo → posible falso negativo)
Úlcera gástrica con H. pylori (+)	Sí
Úlcera gástrica con H. pylori (-)	No

Complicaciones de la Úlcera

- #### 1. Hemorragia Digestiva Alta
- Manejo: SF EV + IBP EV + **endoscopia de urgencia** (inyectoterapia, escleroterapia)

2. Perforación

- Clínica: dolor "en puñalada" epigástrico → se extiende a todo el abdomen, abdomen en tabla, signos peritoneales graves
- Diagnóstico: **Rx de tórax de pie** (buscar neumoperitoneo)
- Tratamiento: **cirugía de urgencia** (sutura + parche de epiplón)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En úlcera **perforada** la endoscopia está **contraindicada** (puede agravar la perforación y aumentar la filtración). Examen de elección → Rx de tórax de pie (no de abdomen). Si no aparece en alternativas → Rx de abdomen de pie.

TABLA 8.7.5: SITUACIÓN VS EXAMEN

SITUACIÓN	EXAMEN	TRATAMIENTO
Úlcera (sin complicaciones)	Endoscopia	Erradicación H. pylori
Úlcera + hemorragia	Endoscopia de urgencia	Endoscopia hemostática
Úlcera + perforación	Rx de tórax de pie	Cirugía de urgencia

Dispepsia Funcional

- Clínica: epigastralgia urente (igual a úlcera o cáncer)
- **Diagnóstico:** endoscopia digestiva alta **normal** → diagnóstico de descarte
- Tratamiento: educación, manejo del estrés, moduladores del dolor; agregar IBP y/o erradicación de H. pylori si hay respuesta sintomática

NOTA CLÍNICA

A diferencia del SII (que es diagnóstico clínico positivo con criterios de Roma), la dispepsia funcional es un **diagnóstico de exclusión** que requiere endoscopia normal.

Helicobacter pylori

- Prevalencia en Chile: **75%** de la población
- Riesgos: úlcera gastroduodenal, cáncer gástrico, **linfoma MALT**

Diagnóstico

- Endoscopia + biopsia (estándar)
- Test de ureasa (test rápido en biopsia)
- Test del aliento con ¹³C-urea (no invasivo)

Esquema de Erradicación

TABLA 8.7.6: LÍNEA VS ESQUEMA

LÍNEA	ESQUEMA	DURACIÓN
Primera línea	Amoxicilina 1 g c/12h + Claritromicina 500 mg c/12h + Omeprazol 20 mg c/12h	14 días
Segunda línea	Tetraciclina + Metronidazol + Omeprazol + Bismuto coloidal	14 días

Control de Erradicación

TABLA 8.7.7: TIPO DE ÚLCERA VS MÉTODO DE CONTROL

TIPO DE ÚLCERA	MÉTODO DE CONTROL
Úlcera gástrica	Endoscopia (descartar cáncer ulcerado)
Úlcera duodenal	Antígeno de H. pylori en deposiciones (menos invasivo)

Indicaciones de Erradicación

TABLA 8.7.8: INDICACIÓN VS FUERZA DE EVIDENCIA

INDICACIÓN	FUERZA DE EVIDENCIA
Úlcera gastroduodenal	Absoluta
Linfoma MALT	Absoluta (¡se trata con antibióticos, no quimio!)
Dispepsia funcional	Relativa
Usuarios de AINEs con H. pylori	Relativa
Metaplasia intestinal gástrica	Relativa
Antecedente familiar de cáncer gástrico	Relativa
Gastritis atrófica	Relativa
RGE	No indicado (no hay asociación)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El linfoma MALT se trata con **erradicación de H. pylori** (antibióticos), NO con quimioterapia. Es uno de los pocos linfomas que regresa con tratamiento antibiótico.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 48 años consulta por pirosis retroesternal y regurgitación ácida de 2 años de evolución que empeora al acostarse. Ha usado antiácidos esporádicos sin mejoría sostenida. No tiene disfagia, ni anemia, ni baja de peso."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE) no complicada: en pacientes < 40-50 años sin signos de alarma, la conducta es prueba terapéutica con Inhibidores de la Bomba de Protones (Omeprazol 20-40 mg/día o Esomeprazol) en ayunas durante 4 a 8 semanas. Si no hay respuesta o si presenta banderas rojas (o pirosis > 5 años con riesgo de Esófago de Barrett), se indica Endoscopia Digestiva Alta.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- RGE: diagnóstico con clínica típica, pH-metría (gold standard ante duda) o hallazgo endoscópico; tratamiento con IBP
- Barrett: metaplasia intestinal esofágica; sin displasia = omeprazol + seguimiento; con displasia = cirugía
- Úlcera: H. pylori es la causa principal; tratamiento = erradicación (no solo omeprazol); omeprazol solo dura 6 semanas
- Úlcera perforada: radiografía de tórax de pie (neumoperitoneo) → cirugía urgente; endoscopia contraindicada
- Dispepsia funcional: diagnóstico de descarte (endoscopia normal)
- Erradicación H. pylori 1a línea: amoxicilina + claritromicina + omeprazol x14 días
- Indicaciones absolutas de erradicación: úlcera y linfoma MALT; NO se erradica en reflujo
- Control post-erradicación: úlcera gástrica con endoscopia; duodenal con antígeno fecal

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (RGE, ÚLCERA GASTRODUODENAL, DISPEPSIA FUNCIONAL Y H. PYLORI)**PREGUNTA 1**

Paciente con úlcera duodenal. El test de ureasa resulta negativo para H. pylori. ¿Cuál es la conducta respecto a la erradicación?

- A)** No erradicar porque H. pylori es negativo
- B)** Erradicar igualmente
- C)** Dar solo omeprazol por 6 semanas
- D)** Repetir endoscopia en 4 semanas
- E)** Solicitar antígeno fecal para confirmar

PREGUNTA 2

Paciente con esófago de Barrett confirmado por biopsia. La biopsia muestra metaplasia intestinal sin displasia. ¿Cuál es el tratamiento indicado?

- A)** Cirugía antirreflujo inmediata
- B)** Omeprazol + seguimiento endoscópico
- C)** Quimioterapia
- D)** Erradicación de H. pylori
- E)** Funduplicatura de Nissen

PREGUNTA 3

Paciente con reflujo gastroesofágico crónico. En la endoscopia se detecta H. pylori positivo. ¿Se debe erradicar?

- A)** Sí, siempre que H. pylori sea positivo
- B)** Sí, porque reduce el riesgo de cáncer esofágico
- C)** No, el reflujo no es indicación de erradicación
- D)** Sí, pero solo con esquema de segunda línea
- E)** Sí, porque mejora los síntomas del reflujo

RESUMEN: RGE, ÚLCERA GASTRODUODENAL, DISPEPSIA FUNCIONAL Y H. PYLORI

Clase que cubre reflujo gastroesofágico (RGE), úlcera gastroduodenal (UGD), dispepsia funcional y manejo de H. pylori. El RGE se diagnostica con clínica típica (pirosis + regurgitación), pH-metría (gold standard ante duda) o hallazgo endoscópico. Se trata con medidas generales e IBP (omeprazol). La UGD se causa por H. pylori (70-90%) y AINEs. El tratamiento es erradicación de H. pylori (no solo omeprazol). La dispepsia funcional es diagnóstico de descarte (endoscopia normal). Se revisa el esófago de Barrett (metaplasia intestinal esofágica, riesgo de cáncer; si displasia de alto grado: cirugía). La erradicación de H. pylori: 1a línea = amoxicilina + claritromicina + omeprazol x14 días; 2a línea = tetraciclina + metronidazol + omeprazol + bismuto. Se erradica siempre en úlcera y linfoma MALT, NO en reflujo.